KronosMedicine

Examen cronometrado: Alergología

20 preguntas · 20 minutos
Aprobatorio: 70%

Nombre: Fecha: Calificación:

Instrucciones: lee cada caso y elige una sola respuesta. Anota tus respuestas en la hoja de respuestas. Tienes 20 minutos; empieza cuando te lo indiquen.

1. Mujer de 25 años que, minutos después de comer cacahuate, presenta ronchas, disnea e hipotensión.
¿Qué tipo de hipersensibilidad explica el cuadro?

A) Tipo II
B) Tipo III
C) Tipo I
D) Tipo IV

2. Hombre de 22 años con estornudos, rinorrea hialina y prurito nasal 5 días por semana desde hace 3 meses; duerme mal por la obstrucción.
¿Cómo se clasifica su rinitis según ARIA?

A) Persistente moderada-grave
B) Intermitente leve
C) Intermitente moderada-grave
D) Persistente leve

3. Mujer de 32 años con ronchas pruriginosas casi diarias desde hace 3 meses que duran unas horas. Sin desencadenante identificado.
¿Cuál es el diagnóstico?

A) Urticaria aguda
B) Urticaria crónica espontánea
C) Urticaria vasculítica
D) Angioedema hereditario

4. Hombre de 30 años picado por una abeja; a los 10 min tiene urticaria generalizada, sibilancias y TA de 80/50.
¿Cuál es el primer tratamiento?

A) Difenhidramina IV
B) Hidrocortisona IV
C) Salbutamol inhalado
D) Adrenalina IM 0.5 mg en el muslo

5. Recién nacido Rh positivo de madre Rh negativa sensibilizada con ictericia y anemia hemolítica.
¿Qué mecanismo produce la hemólisis?

A) IgE y mastocitos
B) Depósito de inmunocomplejos
C) Anticuerpos IgG contra antígenos del eritrocito
D) Linfocitos T citotóxicos tardíos

6. Mujer con rinitis alérgica cuyo síntoma principal es la congestión nasal.
¿Cuál es el fármaco más eficaz?

A) Antihistamínico de 1.ª generación
B) Esteroide intranasal
C) Oximetazolina diaria
D) Antibiótico

7. Paciente con urticaria crónica que no mejora tras 4 semanas de loratadina a dosis estándar.
¿Cuál es el siguiente paso?

A) Aumentar el antihistamínico de 2.ª generación hasta 4 veces
B) Prednisona diaria por 6 meses
C) Cambiar a clorfenamina
D) Suspender todo tratamiento

8. Mujer con anafilaxia que recibió adrenalina IM hace 10 minutos y sigue hipotensa.
¿Cuál es la conducta?

A) Esperar 1 hora a que actúe el esteroide
B) Alta con antihistamínico
C) Repetir la adrenalina IM y dar líquidos IV
D) Dar solo oxígeno

9. Paciente que 10 días después de recibir antiveneno presenta fiebre, artralgias, exantema y proteinuria.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad del suero
B) Anafilaxia
C) Dermatitis por contacto
D) Rechazo hiperagudo

10. Paciente con rinitis alérgica y asma leve persistente que no tolera los esteroides inhalados.
¿Qué fármaco ayuda a ambas condiciones?

A) Montelukast
B) Pseudoefedrina
C) Clorfenamina
D) Cromoglicato ocular

11. Hombre con lesiones urticariformes que duran 3 días, arden más de lo que pican y dejan manchas oscuras.
¿Qué estudio confirma el diagnóstico sospechado?

A) IgE total
B) Prick test
C) Biopsia de piel
D) Perfil tiroideo

12. Paciente atendido por anafilaxia que se recupera por completo a los 30 minutos.
¿Qué indicación es correcta?

A) Alta inmediata
B) Alta sin receta
C) Hospitalizar 7 días
D) Observarlo al menos 6–12 horas

13. Trabajador con prueba de tuberculina leída a las 72 h: induración de 12 mm. No tiene VIH.
¿Cómo se interpreta?

A) Positiva
B) Negativa
C) Dudosa, repetir en 1 semana
D) No válida, debió leerse a las 6 h

14. Hombre que usa oximetazolina nasal todos los días desde hace 2 meses; cada vez necesita más dosis.
¿Cuál es el diagnóstico?

A) Rinitis alérgica persistente
B) Sinusitis bacteriana
C) Rinitis medicamentosa
D) Pólipos nasales

15. Hombre hipertenso que inició enalapril hace 1 mes; presenta edema de labios y lengua sin ronchas ni prurito.
¿Cuál es la conducta más importante?

A) Dar loratadina y continuar el IECA
B) Prick test a alimentos
C) Aumentar la dosis del IECA
D) Suspender el IECA

16. Se quiere confirmar en laboratorio un episodio de anafilaxia ocurrido hace 1 hora.
¿Qué estudio solicitas?

A) IgE total
B) Biometría hemática
C) Triptasa sérica
D) Procalcitonina

17. Mujer con eccema en el lóbulo de las orejas que aparece 2 días después de usar aretes de fantasía.
¿Qué tipo de reacción es?

A) Tipo I
B) Tipo II
C) Tipo IV
D) Tipo III

18. Niño con rinitis alérgica moderada-grave persistente, sensibilizado solo a ácaros, sin control pese a tratamiento óptimo.
¿Qué tratamiento puede cambiar la evolución de la enfermedad?

A) Esteroide sistémico continuo
B) Cirugía de cornetes
C) Inmunoterapia con alérgenos
D) Antihistamínico a dosis cuádruple

19. Urticaria crónica espontánea que no se controla con antihistamínico de 2.ª generación a dosis cuádruple.
¿Qué tratamiento sigue?

A) Antihistamínico de 1.ª generación
B) Antibiótico
C) Dieta de eliminación estricta de por vida
D) Omalizumab

20. Mujer que tuvo anafilaxia por cacahuate y será dada de alta.
¿Qué es lo más importante indicar al alta?

A) Antihistamínico diario de por vida
B) Prednisona preventiva
C) Autoinyector de adrenalina y plan de acción por escrito
D) Evitar solo el ejercicio